Strava a zdravie čreva podľa influencerov: kde vznikajú najčastejšie chyby a čo z nich plynie pre nefrologickú prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Presvedčivá forma ešte nie je dôkaz – a pri chorobe obličiek môže byť „zdravá“ rada priamo riziková.

Tvrdenia influencerov o strave a „zdraví čreva“ bývajú presvedčivé preto, že majú pravdivé jadro, ktoré sa potom neprimerane zovšeobecní. Pri chronickej chorobe obličiek však tieto zovšeobecnenia narážajú na konkrétne čísla a konkrétne riziká. Tento článok prechádza štyri najčastejšie mýty a ukazuje, kde presne sa pri nefrologickom pacientovi lámu.

Prečo sa tým má nefrológ zaoberať

Pacienti prichádzajú s odporúčaniami zo sociálnych sietí častejšie než s odporúčaniami od dietológa. Štyri opakujúce sa témy – bielkoviny, detox, testy potravinovej citlivosti a hmotnosť – sa pritom dotýkajú presne tých oblastí, kde je pri chronickej chorobe obličiek (CKD) riziko vyššie než v bežnej populácii.

Cieľom nie je paušálne odmietnuť všetko, čo zaznie na internete. Väčšina týchto tvrdení má pravdivý základ. Problém vzniká pri prenose na pacienta, u ktorého platia iné hranice.

Mýtus 1: „Pri bielkovinách je viac vždy lepšie“

Čo hovoria dáta

Metaanalýza Mortona a spol. spracovala 49 randomizovaných štúdií s 1 863 účastníkmi a použila analýzu bodu zlomu. Výsledok je jednoznačný: **pri celkovom príjme nad približne 1,62 g bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne už ďalšie zvyšovanie neprinášalo žiadny prírastok beztukovej hmoty** pri silovom tréningu. Účinnosť suplementácie navyše klesala s vekom.

Novšia metaanalýza Nunesa a spol. (74 randomizovaných štúdií) tento obraz dopĺňa: zvýšenie príjmu bielkovín prináša pri silovom tréningu iba *malý* prírastok beztukovej hmoty (štandardizovaný rozdiel priemerov 0,22; 95 % IS 0,14 až 0,30). Účinok bol významný u osôb nad 65 rokov pri príjme 1,2 až 1,59 g/kg/deň a u mladších pri príjme nad 1,6 g/kg/deň.

Tvrdenie „viac je lepšie“ teda nie je nepravdivé – je **ohraničené**. A hranica je známa.

Kde to naráža pri CKD

Odporúčanie KDIGO 2024 pre chronickú chorobu obličiek uvádza:

Kontext	Príjem bielkovín	Zdroj
Prah, nad ktorým už nepribúda svalová hmota	≈ 1,62 g/kg/deň	Morton a spol. 2018
Odporúčaný príjem pri CKD G3–G5 (bez dialýzy)	0,8 g/kg/deň	KDIGO 2024 (odporúčanie 2C)
Hranica, ktorú netreba prekračovať pri riziku progresie	> 1,3 g/kg/deň	KDIGO 2024 (praktický bod)

Kontrast je zreteľný: **prah, pri ktorom sa vo fitness komunite prestáva oplácať ďalší proteín, leží nad hranicou, ktorú KDIGO pri riziku progresie neodporúča prekračovať.** Pacient, ktorý sa riadi obsahom pre zdravých športovcov, sa teda môže úplne legitímne dostať do pásma, pred ktorým nefrologické odporúčanie varuje – bez toho, aby porušil čokoľvek z toho, čo počul.

Aby výklad nebol jednostranný, treba doplniť dve upozornenia. KDIGO neodporúča prísne nízkobielkovinové diéty plošne: veľmi nízky príjem (0,3 až 0,4 g/kg/deň s ketoanalógmi) prichádza do úvahy len pod dohľadom u vybraných pacientov s rizikom zlyhania obličiek, a u metabolicky nestabilných pacientov ani nízko-, ani veľmi nízkobielkovinovú diétu predpisovať netreba. U detí s CKD sa bielkoviny neobmedzujú vôbec pre riziko poruchy rastu. Pacienti na dialýze majú navyše iné, vyššie potreby než pacienti bez dialýzy.

Podrobnejšie sa proteínovým a kreatínovým doplnkom venuje samostatný článok uvedený v prehľade nižšie.

Mýtus 2: „Detox a čistenie čriev odstránia toxíny a resetujú črevo“

Čo hovoria dáta

Prehľad Mishoriovej a spol. hľadal doklady o prínose čistenia hrubého čreva a nenašiel **žiadnu metodologicky spoľahlivú štúdiu**, ktorá by túto prax podporovala. Naopak, zdokumentované poškodenia sú konkrétne: poruchy elektrolytov, sepsa, kolitída, perforácia rekta a úmrtia. V opísanom prepuknutí amébózy pripisovanom kolonickej irigácii v jedinom zariadení sa infikovalo najmenej 36 pacientov, 10 potrebovalo kolektómiu a šiesti zomreli.

Koncept „detoxifikácie“ je pritom medicínsky nepresný. Pečeň, obličky, pľúca, črevo a koža *sú* eliminačný systém a pracujú nepretržite. Krátkodobý úbytok hmotnosti po „detoxe“ sa vysvetľuje energetickým deficitom, zmenou obsahu čreva a stratou tekutín – nie odstránením toxínov.

Kde to naráža pri CKD – a jeden konkrétny renálny mechanizmus

Poruchy elektrolytov a dehydratácia sú pri CKD závažnejšie a menej reverzibilné než u zdravého človeka. Existuje však aj priamy renálny mechanizmus s vlastným menom.

Akútna fosfátová nefropatia je poškodenie obličiek s tubulárnymi depozitmi fosforečnanu vápenatého po prípravkoch na čistenie čriev obsahujúcich perorálny sodný fosfát. Markowitz a spol. opísali 21 takýchto pacientov, u ktorých sa pri normálnej kalcémii rozvinulo akútne zlyhanie obličiek po vyčistení čreva perorálnym sodným fosfátom – a označili tento stav za *nedostatočne rozpoznávanú príčinu chronického zlyhania obličiek*.

To je zásadný rozdiel oproti bežnej predstave: nejde o teoretické riziko dehydratácie, ale o histologicky doloženú entitu, ktorá môže zanechať trvalé poškodenie. Pacientovi s CKD, ktorý uvažuje o „prečistení“ pomocou laxatívnych prípravkov neznámeho zloženia, treba toto povedať priamo.

Mýtus 3: „IgG test ukáže, ktoré potraviny mi zapaľujú črevo“

Čo hovoria odborné spoločnosti

Stanovisko Kanadskej spoločnosti pre alergiu a klinickú imunológiu (CSACI) k testovaniu potravinovo špecifických IgG je jednoznačne odmietavé – test sa neodporúča na diagnostiku potravinovej alergie ani intolerancie. Rovnaké stanovisko zastáva Americká akadémia alergie, astmy a imunológie.

Dôvod je imunologický: **prítomnosť špecifických IgG proti potravine odráža expozíciu tejto potravine, nie patologickú reakciu na ňu.** Vysoké IgG voči mlieku znamená predovšetkým to, že daný človek pije mlieko. Pozitívny výsledok tak nemá diagnostickú hodnotu, ale má reálne dôsledky – vedie k vylúčeniu často desiatok potravín.

Kde to naráža pri CKD

Neodôvodnené reštrikcie sú v tejto populácii obzvlášť rizikové. Pacient s CKD už spravidla obmedzuje fosfor, draslík a sodík; strava sa mu teda zužuje aj bez ďalších zákazov. Pridanie rozsiahleho zoznamu „zápalových“ potravín podľa IgG testu zvyšuje riziko nedostatočného príjmu energie a bielkovín, deficitu mikroživín a v konečnom dôsledku sarkopénie a krehkosti – teda presne toho, čo prognózu pri CKD zhoršuje.

Praktický postup: ak pacient príde s výsledkom IgG testu, nie je vhodné ho zosmiešniť. Užitočnejšie je vysvetliť, čo test v skutočnosti meria, a ponúknuť riadny postup – cielenú anamnézu, prípadne alergologické alebo gastroenterologické vyšetrenie, a pri podozrení na intoleranciu štruktúrovanú eliminačno-expozičnú skúšku pod dohľadom.

Mýtus 4: „Nižšia hmotnosť je vždy zdravšia“

Čo je na tom nepresné

BMI nerozlišuje tukovú a svalovú hmotu, nehovorí nič o rozložení tuku ani o funkčnom stave. Ako samostatný ukazovateľ zdravia je preto hrubý.

Kde to naráža pri CKD

V nefrologickej populácii je táto výhrada obzvlášť podstatná. Sarkopénia, krehkosť a zmeny telesného zloženia sú pri pokročilej CKD a na dialýze bežné. Pacient môže mať „normálne“ BMI a súčasne výrazne zníženú svalovú hmotu a silu. Riadiť sa iba hmotnosťou znamená prehliadnuť to, čo skutočne predpovedá výsledok.

Informatívnejšie sú:

- funkčný stav – sila stisku ruky, chôdzová rýchlosť, test vstávania zo stoličky,
- nutričný stav vrátane príjmu energie a bielkovín,
- telesné zloženie tam, kde je dostupné,
- krvný tlak a metabolický profil,
- kvalita života a sebestačnosť.

Osobitnú opatrnosť si vyžaduje neplánovaný úbytok hmotnosti u dialyzovaného pacienta – ten nie je úspechom, ale varovným znamením.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Pri bielkovinách je viac vždy lepšie	**Ohraničene nepravdivé**	Nad ≈ 1,62 g/kg/deň už žiadny ďalší prírastok beztukovej hmoty (49 štúdií, 1 863 účastníkov)
Bielkoviny sú pre svalovú hmotu dôležité	**Potvrdené, ale účinok je malý**	SMD 0,22 (95 % IS 0,14–0,30) pri silovom tréningu
Odporúčania pre športovcov platia aj pri CKD	**Nie**	KDIGO 2024: 0,8 g/kg/deň pri G3–G5, neprekračovať 1,3 g/kg/deň pri riziku progresie
Detox diéta odstráni toxíny a resetuje črevo	**Nepodložené**	Žiadna metodologicky spoľahlivá štúdia; eliminačné orgány pracujú nepretržite
Čistenie čriev je neškodné	**Nepravdivé**	Doložené poruchy elektrolytov, sepsa, kolitída, perforácia, úmrtia; pri amébóze z irigácie ≥ 36 infikovaných, 10 kolektómií, 6 úmrtí
Prípravky na čistenie čriev nemajú renálne riziko	**Nepravdivé**	Akútna fosfátová nefropatia po perorálnom sodnom fosfáte – 21 opísaných pacientov, možné trvalé poškodenie
IgG test ukáže potraviny vyvolávajúce zápal	**Nepodložené na diagnostiku**	IgG odráža expozíciu, nie patologickú reakciu; CSACI aj AAAAI test neodporúčajú
Nižšie BMI je automaticky zdravšie	**Zjednodušenie**	BMI nerozlišuje tuk od svalu ani nezachytáva funkciu; pri CKD je informatívnejší funkčný a nutričný stav

Čo z toho vyplýva pre rozhovor s pacientom

1. **Nezačínať odmietnutím.** Každý zo štyroch mýtov má pravdivé jadro. Pacient, ktorý sa cíti zosmiešnený, sa nabudúce nespýta a poradí sa opäť na internete.
2. **Pomenovať hranicu, nie zákaz.** Pri bielkovinách funguje konkrétne číslo lepšie než všeobecné „menej“: existuje prah, nad ktorým prínos mizne, a pri CKD leží ešte nižšie.
3. **Pri „detoxe“ hovoriť o mechanizme.** Akútna fosfátová nefropatia je konkrétnejší argument než abstraktné „môže to uškodiť“.
4. **Pri IgG teste vysvetliť, čo test meria.** Nie „je to nezmysel“, ale „meria to, čo jete, nie to, čo vám škodí“.
5. **Namiesto hmotnosti sledovať funkciu.** Sila stisku ruky a chôdzová rýchlosť sú pri CKD výpovednejšie než číslo na váhe.
6. **Pýtať sa aktívne na doplnky a kúry.** Pacienti ich spontánne neuvádzajú, lebo ich nepovažujú za lieky.

Praktický záver

Obsah influencerov o strave a zdraví čreva zvyčajne nestojí na výmysle, ale na neprimeranom zovšeobecnení pravdivého jadra. Pre nefrologickú prax je podstatné, že tieto zovšeobecnenia sa lámu presne tam, kde má pacient s CKD iné hranice než zdravý dospelý.

Konkrétne: fitness prah príjmu bielkovín leží nad stropom, ktorý KDIGO pri riziku progresie neodporúča prekračovať; „čistenie čriev“ má okrem chýbajúceho prínosu aj doloženú renálnu toxicitu; IgG testy vedú k reštrikciám, ktoré v tejto populácii hrozia sarkopéniou; a hmotnosť sama osebe nehovorí o funkčnom stave, na ktorom pri CKD záleží najviac.

Súvisiace články

- Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plynie pre nefrológiu
- Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu
- Vyšší príjem bielkovín a funkcia obličiek: desaťročná kohorta nezistila rýchlejší pokles meranej GFR

- Frailty pri chronickej chorobe obličiek: prečo nestačí sledovať iba eGFR
- Neceliakálna citlivosť na pšenicu: spúšťačom nemusí byť iba glutén

Zdroje

1. **Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, Schoenfeld BJ, Henselmans M, Helms E, Aragon AA, Devries MC, Banfield L, Krieger JW, Phillips SM.** *A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults.* Br J Sports Med. 2018;52(6):376–384. doi: 10.1136/bjsports-2017-097608. Zdroj prahu 1,62 g/kg/deň. Metaanalýza; PubMed.
2. **Nunes EA, Colenso-Semple L, McKellar SR, Yau T, Ali MU, Fitzpatrick-Lewis D, Sherifali D, Gaudichon C, Tomé D, Atherton PJ, Robles MC, Naranjo-Modad S, Braun M, Landi F, Phillips SM.** *Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults.* J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2022;13(2):795–810. doi: 10.1002/jcsm.12922. Metaanalýza 74 štúdií; PubMed.
3. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2024;105(4 Suppl):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. Zdroj odporúčania 0,8 g/kg/deň a praktického bodu o hranici 1,3 g/kg/deň. Odporúčanie KDIGO.
4. **Mishori R, Otubu A, Jones AA.** *The dangers of colon cleansing.* J Fam Pract. 2011;60(8):454–457. Prehľad dôkazov a poškodení pri čistení hrubého čreva. PubMed.
5. **Markowitz GS, Stokes MB, Radhakrishnan J, D'Agati VD.** *Acute phosphate nephropathy following oral sodium phosphate bowel purgative: an underrecognized cause of chronic renal failure.* J Am Soc Nephrol. 2005;16(11):3389–3396. Séria 21 pacientov s akútnou fosfátovou nefropatiou. PubMed.
6. **Carr S, Chan E, Lavine E, Moote W.** *CSACI Position statement on the testing of food-specific IgG.* Allergy Asthma Clin Immunol. 2012;8(1):12. doi: 10.1186/1710-1492-8-12. Stanovisko CSACI; PubMed.
7. **American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).** *IgG food test.* Inštitucionálne autorstvo. Stanovisko AAAAI.
8. **Medscape Medical News.** *What Influencers Get Wrong About Diet and Gut Health.* Medscape, 2026. Sekundárny zdroj použitý ako východisko témy, nie ako dôkaz; ako autorka sa uvádza Charlotte Markey. Spravodajské spracovanie.

Poznámka k spracovaniu: *Prah 1,62 g/kg/deň, počet 49 štúdií a 1 863 účastníkov boli overené proti abstraktu v PubMed (PMID 28698222); údaje druhej metaanalýzy (74 štúdií, SMD 0,22; 95 % IS 0,14–0,30, pásma 1,2–1,59 a ≥ 1,6 g/kg/deň) proti PMID 35187864; séria 21 pacientov s akútnou fosfátovou nefropatiou proti PMID 16192415; stanovisko CSACI proti PMID 22835332. Odporúčanie 0,8 g/kg/deň (2C) a praktický bod o neprekračovaní 1,3 g/kg/deň pochádzajú z odporúčania KDIGO 2024 pre CKD.* ***Oprava oproti pôvodnému podkladu:*** *ako doklad o „čistení čriev“ bola v podklade uvedená práca Restelliniho a spol. (World J Gastroenterol 2017), tá sa však týka prípravy čreva pred kolonoskopiou pri nešpecifických zápaloch čreva, nie detoxových praktík – bola nahradená prehľadom Mishoriovej a spol. Autorstvo spravodajského spracovania Medscape sa pre obmedzený prístup nepodarilo nezávisle overiť a uvádza sa s výhradou.*

Poznámka k interpretácii: *Príjem bielkovín, obmedzenia stravy a nutričné intervencie pri chronickej chorobe obličiek treba stanoviť individuálne podľa štádia ochorenia, dialyzačnej liečby, nutričného stavu a rizika sarkopénie, v spolupráci s nutričným terapeutom a podľa platných odporúčaní. Uvedené prahy sú orientačné hodnoty z populačných štúdií a odporúčaní, nie predpis pre konkrétneho pacienta.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=strava-a-zdravie-creva-myty-influencerov-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.